

Mity vs fakty

Schizofrenia jest najsilniej stygmatyzowaną chorobą psychiczną. Mity są głęboko zakorzenione w mediach i języku. Fakty wyglądają inaczej. Karta do rozmowy z otoczeniem.

CZAS: 15 min Po diagnozie · do edukacji bliskich

ŹRÓDŁO: Sartorius (1997, WPA); Jaaskelainen i in. (2013); Teplin (2005); Lawrence & Kisely (2010)

JAK UŻYWAĆ

Skonfrontuj **trzy najpopularniejsze mity** o psychozie z faktami opartymi na badaniach (sekcja 1), zrozum problem **diagnostic overshadowing** w opiece somatycznej (sekcja 2), poznaj **język person-first** (sekcja 3) i przykłady osób żyjących pełnią z psychozą (sekcja 4).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sartorius (1997) zapoczątkował program *Opening Doors* Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA) — globalną kampanię przeciwko stygmie schizofrenii. Po 25 latach kampanii — postępy są **częściowe**, mity utrzymują się. Jaaskelainen i in. (2013, meta-analiza 50 badań na ~9 000 pacjentów): **13-50% osób z psychozą osiąga pełne recovery** — definiowane jako brak istotnych objawów + dobre funkcjonowanie społeczne i zawodowe. To znacząco więcej niż sugerują media. Teplin i in. (2005, badanie populacyjne): osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi są **10x częściej ofiarami** przemocy niż jej sprawcami. Mity zabijają — Lawrence & Kisely (2010) opisują *diagnostic overshadowing*: lekarze somatyczni przypisują objawy fizyczne „psychozie”, pomijając realne choroby. To bezpośrednio przyczynia się do 15-20 lat krótszego życia.

01 = Trzy najgroźniejsze mity

MIT · „ROZDWOJENIE OSOBOWOŚCI”

„Schizofrenia to dwie osobowości w jednej”. Najczęstszy mit, podtrzymywany przez filmy. Nazwa „schizo-frenia” oznacza dosłownie „rozszczepiony umysł” — ale Bleuler (1911) miał na myśli rozdarcie między *myślą a emocją*, nie między dwiema osobowościami.

✓ FAKT

Schizofrenia to zaburzenie myślenia, percepcji i emocji w jednej tożsamości. *Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości* (DID, „rozdwojenie osobowości”) to **inna** jednostka diagnostyczna, rzadka, najczęściej związana z traumą.

MIT · „NIEBEZPIECZNI I NIEPRZEWIDYWALNI”

Najbardziej szkodliwy mit, powielany przez media („chory psychicznie napastnik”). Bezpośrednio zwiększa wykluczenie społeczne.

✓ FAKT

Teplin (2005): osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi są **10x częściej ofiarami** przemocy niż sprawcami. Ryzyko przemocy *nieznacznie* wyższe tylko przy współtowarzyszącym używaniu substancji.

MIT · „NIEULECZALNA, CAŁE ŻYCIE”

„Schizofrenia to wyrok”. Otoczenie traci nadzieję, pacjent przestaje próbować, klinicysta nastawia się na podtrzymanie objawów.

✓ FAKT

Jaaskelainen i in. (2013, meta-analiza 50 badań): **13-50% osób osiąga pełne recovery**. Większość żyje w stanie funkcjonalnym z umiarkowanymi objawami. To *nie* wyrok.

02 ☉ **Diagnostic overshadowing** — gdy lekarz nie widzi reszty

Lawrence & Kisely (2010): zjawisko polegające na tym, że lekarze somatyczni **przypisują** realne objawy fizyczne diagnozie psychiatrycznej, pomijając rozpoznanie. Pacjent z bólem brzucha trafia na SOR, w karcie widać „*schizofrenia*” — lekarz interpretuje ból jako „*somatyzację*”, a wyrostek pęka.

SKUTKI

Opóźnione diagnozy, niedoleczone choroby, śmierć z powodu chorób somatycznych. Element 15–20 lat krótszego życia. Strukturalne, nie indywidualne.

CO ZROBIĆ

- Zabieraj bliską osobę
- Mów konkretnie: „*boli mnie tu, od X dni*”
- Masz prawo do drugiej opinii
- Lekarz POZ poza psychiatrią

03 💡 **Język ma znaczenie** — *person-first language*

JĘZYK STYGMATYZUJĄCY

- „*schizofrenik*”, „*psychotyk*”
- „*świr*”, „*wariat*”
- „*jest schizofrenikiem*” (tożsamość = choroba)

JĘZYK PERSON-FIRST

- „*osoba z psychozą / ze schizofrenią*”
- „*osoba doświadczająca głosów*”
- „*ma psychozę*” (choroba ≠ tożsamość)

04 💡 **Osoby, które żyją pełnią z psychozą**

ELYN SAKS

Profesor prawa Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Autorka „*Niewytłumaczone*” — wspomnień. Żyje z diagnozą schizofrenii.

ELEANOR LONGDEN

Psycholożka kliniczna, autorka popularnego wykładu TED „*Głosy w mojej głowie*”. Liderka ruchu Hearing Voices.

PATRICIA DEEGAN

Psycholożka kliniczna, jedna z fundatorek paradygmatu recovery. Diagnozę schizofrenii otrzymała w wieku 17 lat.

Klucz: diagnoza psychozy to **nie koniec historii** — to *rozdział*, z którym można żyć pełnią i z godnością. Mity są głęboko zakorzenione w kulturze, ale fakty wyglądają inaczej. 13–50% pełne *recovery*, większość żyje funkcjonalnie. Sartorius (1997) i program *Opening Doors* WPA: **najskuteczniejszą** bronią przeciwko stygmie jest *kontakt* — spotkanie z osobą żyjącą z psychozą zmienia przekonania bardziej niż wszystkie kampanie informacyjne razem. Gdy jesteś gotowy/-a — Twoja własna historia może być częścią tej zmiany. Ale to *wyłącznie* Twoja decyzja. Najpierw Ty zasługujesz na wsparcie i ochronę — dopiero potem ewentualnie na rolę edukacyjną.